

Obstruction des voies urinaires (UTO)

Définition

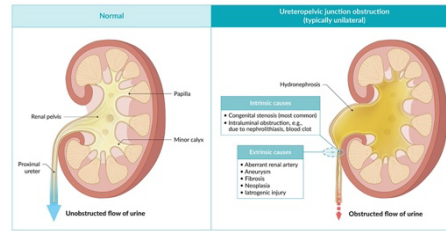
Blocage mécanique ou fonctionnel qui empêche l'écoulement de l'urine à travers le tractus urinaire. Cette condition peut affecter n'importe quelle partie des voies urinaires, et son étiologie, ses manifestations cliniques, et son traitement varient en fonction du site, de la gravité et de la durée de l'obstruction.

Étiologie

Les causes d'obstruction des voies urinaires se divisent en deux catégories principales : l'obstruction des voies urinaires supérieures et celle des voies urinaires inférieures.

Obstruction des voies urinaires supérieures

- ? **Obstruction rénale :**
 - Néphrolithiase (calculs rénaux)
 - Carcinome du bassinet
 - Obstruction de la jonction pyélo-urétérale
 - Nécrose papillaire rénale
- ? **Obstruction urétérale :**
 - **Intraluminale** : calculs rénaux, caillots sanguins
 - **Intramurale** : sténose urétérale (strictures malignes ou bénignes), carcinome urétéral, ligature accidentelle
 - **Extraluminale** : compression par des structures adjacentes (grossesse, néoplasie, fibrose rétropéritonéale)



Obstruction des voies urinaires inférieures

- ? **Obstruction de la vessie :**
 - Carcinome vésical
 - Vessie neurogène
 - Tamponnade vésicale (caillots sanguins)
 - Calculs vésicaux
- ? **Obstruction urétrale :**
 - Hypertrophie prostatique bénigne ou cancer de la prostate
 - Valves urétrales postérieures (congénital)
 - Sténose urétrale
 - Carcinome urétral

Manifestations cliniques

Les symptômes varient selon la localisation, le degré et la durée de l'obstruction. Les obstructions aiguës peuvent se présenter par une douleur intense, une anurie, ou des signes d'infection (fièvre, frissons). Les obstructions chroniques, quant à elles, sont souvent asymptomatiques jusqu'à ce que des complications surviennent, telles qu'une infection urinaire ou une insuffisance rénale.

Prise en charge

La prise en charge dépend de la cause, du site et de la gravité de l'obstruction.

- ? **Urgence médicale** : Les UTO accompagnées d'insuffisance rénale aiguë, de signes de sepsis, de douleur réfractaire, ou d'anurie nécessitent une prise en charge rapide avec un drainage des voies urinaires via une sonde vésicale, un stent urétéral, ou une néphrostomie percutanée.
- ? **Obstruction des voies urinaires supérieures :**
 - Consultation en urologie pour un traitement définitif.
 - Stent urétéral ou néphrostomie percutanée pour le drainage.
 - Néphro-urétérectomie si le rein est non fonctionnel.
- ? **Obstruction des voies urinaires inférieures :**
 - Cathétérisme vésical pour traiter la rétention urinaire.
 - Surveillance de la diurèse post-obstructive.
- ? **Soins de soutien :**
 - Analgésiques (AINS, opioïdes)
 - Antibiotiophylaxie avant les procédures invasives si nécessaire.

Conclusion

L'obstruction des voies urinaires est une pathologie potentiellement grave nécessitant une évaluation et une gestion appropriées pour prévenir les complications telles que l'insuffisance rénale ou les infections urinaires. Le traitement varie en fonction de l'étiologie spécifique et de la localisation de l'obstruction.

Hydronéphrose

L'hydronéphrose est une dilatation du bassin et des calices rénaux due à une obstruction du flux urinaire en amont du site de l'obstruction.

Classification

- ② L'hydronéphrose est classée de grade I à IV en fonction de sa gravité.

Étiologie

Les causes courantes de l'hydronéphrose incluent :

- ② Obstruction des voies urinaires, par exemple, due à une fibrose rétropéritonéale ou une obstruction vésicale.
- ② Reflux vésico-urétéral, où l'urine reflue des voies urinaires inférieures vers les voies supérieures.

Symptômes typiques

L'hydronéphrose peut être asymptomatique si isolée. Les symptômes dépendent de l'étiologie et des conditions associées, tels que :

- ② Douleur au flanc, dorsale et/ou abdominale
- ② Oligurie (diminution de la production d'urine)
- ② Fièvre et signes d'infection urinaire (pyonéphrose)

Diagnostic

Le diagnostic repose principalement sur l'échographie, qui révèle une dilatation anéchogène du bassin et des calices rénaux avec distension du parenchyme rénal sain.

Pronostic

Les dommages rénaux peuvent être réversibles si le flux urinaire est rétabli rapidement. Cependant, une hydronéphrose chronique ou une hydronéphrose aiguë non résolue rapidement peut entraîner une atrophie tubulaire ischémique, un amincissement du cortex et de la médulla rénale, et une perte irréversible de la fonction rénale.

Points importants

Il est crucial de considérer les malignités gynécologiques (par exemple, cancer du col de l'utérus, utérin, ovarien) chez les femmes non enceintes présentant une hydronéphrose nouvellement apparue.

